# Hồ sơ thực hiện tiêu chí A2.1

**Người bệnh điều trị nội trú được nằm một người một giường**

**BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN**

Dự thảo trình duyệt năm 2026. Bộ hồ sơ cung cấp ma trận yêu cầu, quy định triển khai đề xuất, kế hoạch, chỉ số và biểu mẫu để các đơn vị bổ sung minh chứng thực tế. Chưa có căn cứ kết luận mức đạt của bệnh viện.

Số văn bản và phiên bản .....

Ngày phê duyệt và áp dụng .....

Người soạn thảo .....

Người rà soát .....

Người phê duyệt .....

## Đầu mối và cách sử dụng

Phòng Kế hoạch tổng hợp phối hợp Phòng Điều dưỡng, các khoa và bộ phận quản trị cơ sở vật chất. Đây là phân công đề xuất, phải xác nhận với cơ cấu và thẩm quyền thực tế trước ký.

Không ghi lùi ngày, tạo chữ ký hoặc điền số liệu thay cho hoạt động chưa thực hiện. Mã biểu mẫu là mã đề xuất, cần thống nhất với quản lý tài liệu bệnh viện. Hồ sơ tiêu chí quản lý không bị ép theo đề cương quy trình kỹ thuật QĐ3023.

## 1 Căn cứ và nguyên tắc đối chiếu

Căn cứ trực tiếp: QĐ6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016, Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0, A2.1, trang in 26 [1]. Ma trận sau diễn giải rút gọn, giữ số mục và mức để tra cứu cùng bản gốc.

Bộ phận QLCL và pháp chế đối chiếu thêm hướng dẫn kiểm tra của kỳ đánh giá thực tế; không mặc định mọi viện dẫn trong phần căn cứ lịch sử năm 2016 còn hiện hành. Các nội dung quyền người bệnh thực hiện theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 và văn bản liên quan hiện hành.

Kiểm tra tình trạng bất lợi mức 1 trước. Khi có tình trạng mức 1, xử lý và đánh giá theo hướng dẫn của Bộ tiêu chí; không biến tình trạng đó thành yêu cầu tích cực. Nếu không có tình trạng mức 1, đối chiếu tích lũy mức 2–5, không lấy trung bình số ô đáp ứng để xếp mức.

Giường tạm theo ghi chú tiêu chí là băng ca, giường gấp, ghế ngả có tính di động; thống kê riêng, không tự đổi tên thành giường y tế đạt chuẩn.

Đối chiếu nguyên văn tiểu mục 7 về ngoại lệ 48 giờ; không mặc định Bệnh viện Nhật Tân thuộc nhóm ngoại lệ. Kế hoạch nội bộ lấy mục tiêu mỗi người một giường ngay khi bố trí và theo dõi mốc 24 giờ.

Việc tiêu chí nhắc tới giường hành lang không tự cấp phép bố trí giường tại hành lang. Mọi phương án phải đáp ứng điều kiện hoạt động, kiểm soát nhiễm khuẩn, lối thoát nạn, tiếp cận cấp cứu và an toàn công trình.

## 2 Ma trận tiểu mục 1 đến 10

| Mục mức | Nội dung đối chiếu | Minh chứng cần có |
|---|---|---|
| 1 M1 | Có nằm ghép từ ba người bệnh trở lên trên một giường trong năm, trừ thiên tai, thảm họa và dịch truyền nhiễm | Nhật ký toàn năm, sự cố và hồ sơ tình huống ngoại lệ. |
| 2 M2 | Buồng bệnh không dột nát, tường không bong tróc hoặc ẩm mốc | Biên bản kiểm tra và sửa chữa. |
| 3 M2 | Người bệnh nặng tại hồi sức, sau mổ, kết nối thiết bị, truyền nhiễm, nhiễm khuẩn bệnh viện hoặc nguy cơ lây nhiễm cao được nằm riêng một giường | Danh sách đối tượng ưu tiên và quan sát thực tế. |
| 4 M2 | Quan tâm bố trí giường riêng cho người cao tuổi và đối tượng ưu tiên khác | Quy định, phân bổ và phỏng vấn. |
| 5 M2 | Có sổ hoặc phần mềm theo dõi nhập, xuất viện tại khoa | Sổ hoặc dữ liệu hệ thống có thể truy vết. |
| 6 M2 | Có thống kê lượt nội trú, giường và giường tạm từng khoa | Bảng kiểm kê và thống kê thống nhất. |
| 7 M3 | Không nằm ghép hai người sau 24 giờ nhập viện; ngoại lệ 48 giờ chỉ cho nhóm bệnh viện được nêu trong bản gốc | Giờ nhập viện, thời điểm bắt đầu và chấm dứt nằm ghép. |
| 8 M3 | Tất cả người bệnh nằm mỗi người một giường trong buồng hoặc hành lang | Kiểm tra đột xuất và hồ sơ bố trí giường. |
| 9 M3 | Giường trong buồng hoặc hành lang không bị dột, hắt nước mưa | Quan sát, phản ánh và kiểm tra sau mưa. |
| 10 M3 | Người cao tuổi được ưu tiên vị trí thuận tiện đi lại, tầng và vệ sinh khi có điều trị người cao tuổi | Phân bổ giường và kiểm tra tính thuận tiện. |

Kết quả từng dòng: ghi tại phiếu tự đánh giá cuối hồ sơ. Dẫn mã minh chứng và vị trí tra cứu; quan sát một thời điểm không thay thế yêu cầu theo dõi cả năm khi tiêu chí có quy định.

## 2 Ma trận tiểu mục 11 đến 17

| Mục mức | Nội dung đối chiếu | Minh chứng cần có |
|---|---|---|
| 11 M3 | Bố trí khu nam nữ riêng hoặc buồng nam nữ riêng | Sơ đồ và quan sát thực tế. |
| 12 M3 | Giường chắc chắn, được sửa hoặc thay kịp thời khi hỏng | Kiểm kê, bảo trì và nghiệm thu. |
| 13 M4 | Mỗi người một giường theo quy chuẩn giường y tế, trong buồng hoặc hành lang | Thông số, hồ sơ thiết bị và thực |
| 14 M4 | Người bệnh điều trị trong buồng nam và nữ riêng biệt | Sơ đồ, danh sách và kiểm tra. |
| 15 M5 | Mỗi người một giường trong buồng bệnh ở mọi thời điểm trong năm | Dữ liệu cả năm và kiểm tra nhiề điểm. |
| 16 M5 | Giường cùng buồng thống nhất kiểu dáng, kích thước, chất liệu | Danh mục và quan sát từng buồ |
| 17 M5 | Giường có tính năng an toàn, tiện lợi: đầu cao, bánh xe, bàn ăn, nâng hạ | Hồ sơ thiết bị, kiểm tra chức nă trì. |

Kết quả từng dòng: ghi tại phiếu tự đánh giá cuối hồ sơ. Dẫn mã minh chứng và vị trí tra cứu; quan sát một thời điểm không thay thế yêu cầu theo dõi cả năm khi tiêu chí có quy định.

## 3 Quy định triển khai đề xuất

Mục tiêu: Người bệnh điều trị nội trú được nằm một người một giường. Phạm vi bao gồm các đơn vị liên quan trực tiếp và bộ phận hỗ trợ. Ban Giám đốc phê duyệt quy định, nguồn lực và phân cấp; trưởng đơn vị tổ chức thực hiện, giám sát và xử lý phát sinh; QLCL tổng hợp kết quả và theo dõi cải tiến.

### Tiếp nhận và xác định nhu cầu

Kiểm tra người bệnh, tình trạng, chỉ định nội trú, nguy cơ lây nhiễm, nhu cầu thiết bị và khả năng vận động; xác định nhóm cần giường riêng, vị trí thuận tiện và phương án cách ly theo chuyên môn.

### Chốt giường khả dụng

Cập nhật giường thực kê, giường có thể sử dụng, đang có người bệnh, hỏng hoặc tạm ngừng, giường tạm; không tính giường hỏng vào năng lực tiếp nhận an toàn. Phân biệt giường kế hoạch được giao và giường thực kê.

### Bố trí và giải thích

Phối hợp khoa tiếp nhận, bố trí đúng nhu cầu chuyên môn, nam nữ và ưu tiên; ghi mã giường, vị trí, giờ nhận. Giải thích cho người bệnh, hỗ trợ chuyển an toàn, vệ sinh giường giữa các lượt.

## 4 Xử lý tình huống và kiểm soát thực hiện

### Xử lý khi thiếu giường

Báo đầu mối điều phối và lãnh đạo trực; huy động giường khả dụng đúng chức năng, điều chuyển phù hợp hoặc phối hợp chuyển viện an toàn theo quyết định chuyên môn. Không trì hoãn cấp cứu vì thiếu giường. Mỗi trường hợp chờ/nằm ghép phải có thời điểm, lý do, người chịu trách nhiệm và theo dõi đến khi giải quyết.

### Kiểm tra và khắc phục

Đối chiếu số người bệnh với từng giường theo ca và khi biến động; kiểm tra mốc 24 giờ. Theo dõi suốt năm bằng dữ liệu và kiểm tra đột xuất; không chỉ dùng ảnh ngày đánh giá. Giường hỏng hoặc khu dột phải được cảnh báo, ngừng dùng khi không an toàn và sửa chữa.

## Ghi nhận và kiểm soát minh chứng

Ghi đúng thời điểm, người thực hiện, kết quả và việc chưa hoàn thành. Phân quyền truy cập, dùng mã thay dữ liệu định danh trong báo cáo tổng hợp; giữ hồ sơ chi tiết ở nơi được phép. Chứng cứ ảnh phải có bối cảnh, thời gian và mục đích phù hợp, không công khai thông tin người bệnh trái quy định.

Tài liệu và bảng nhắc cần được rà soát chuyên môn, phê duyệt đúng thẩm quyền, cấp phiên bản và phổ biến. Khi thay đổi phải thu hồi bản cũ và hướng dẫn lại. Đào tạo có nội dung, danh sách tham dự thật, kiểm tra khả năng thực hiện và kế hoạch học bù.

## 5 Kế hoạch triển khai và đo lường

T0 là ngày phê duyệt thực tế. Lịch dưới đây là đề xuất để đơn vị điều chỉnh theo nguồn lực; không phải lịch bắt buộc do Bộ tiêu chí ấn định.

| Thời hạn | Công việc | Sản phẩm |
|---|---|---|
| T0 + 15 ngày | Khảo sát từng tiểu mục, xác định khoảng thiếu. | Dữ liệu nền và phân công. |
| T0 + 30 ngày | Trình quy định, công cụ, nguồn lực và đào tạo. | Văn bản được duyệt và hồ sơ phổ b |
| T0 + 60 ngày | Triển khai, kiểm tra thực hành, ghi dữ liệu. | Biểu mẫu thực tế và xử lý tồn tại. |
| T0 + 90 ngày | Đánh giá, phản hồi, cải tiến và đo lại. | Báo cáo và hành động theo dõi. |

### Một người một giường tại thời điểm kiểm tra

Số người bệnh có giường riêng / tổng người bệnh nội trú đang hiện diện × 100%. Báo riêng giường tạm, giường hành lang và giường trong buồng.

### Nằm ghép quá 24 giờ

Số trường hợp còn nằm ghép sau 24 giờ tính từ giờ nhập viện; kèm danh sách, diễn biến và thời gian giải quyết. Không dùng tỷ lệ bình quân che trường hợp vi phạm.

### Sự kiện ba người trở lên trên một giường

Đếm sự kiện thực tế trong năm; xác minh ngoại lệ đúng phạm vi tiêu chí, không tự coi quá tải thông thường là ngoại lệ.

Trước đo phải khóa định nghĩa, kỳ, mẫu số và cách chọn đối tượng. Mẫu số bằng 0 ghi không tính được; thiếu dữ liệu ghi chưa xác minh. Không làm tròn dưới ngưỡng thành đạt hoặc suy rộng một mẫu nhỏ thành toàn bộ bệnh viện.

## 6 BM01 Sổ điều phối giường

Mã đề xuất A21 BM01.

Ngày giờ, khoa, người ghi và kỳ thống kê .....

Người ghi và đơn vị .....

| Mã giường và vị trí | Loại và khả dụng | Mã đợt người bệnh | Giờ nhận hoặc trả |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Nhận xét, tồn tại hoặc thông tin cần xác minh .....

Hành động tiếp theo, người phụ trách và hạn .....

Người kiểm tra, ngày và kết quả xác nhận .....

Ghi theo thực tế, không xác nhận trước; lưu trong hệ thống được phân quyền. Cần thêm dòng thì sao chép trang biểu mẫu hoặc tích hợp vào hệ thống chính thức.

## 6 BM02 Theo dõi chờ giường hoặc nằm ghép

Mã đề xuất A21 BM02.

Mã đợt, giờ nhập viện, khoa và người chịu trách nhiệm .....

Người ghi và đơn vị .....

| Thời điểm | Số người trên giường | Giải pháp và người xử lý | Giờ giải quyết |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Nhận xét, tồn tại hoặc thông tin cần xác minh .....

Hành động tiếp theo, người phụ trách và hạn .....

Người kiểm tra, ngày và kết quả xác nhận .....

Ghi theo thực tế, không xác nhận trước; lưu trong hệ thống được phân quyền. Cần thêm dòng thì sao chép trang biểu mẫu hoặc tích hợp vào hệ thống chính thức.

## 6 BM03 Kiểm tra cơ sở vật chất

Mã đề xuất A21 BM03.

Khoa, buồng, ngày và người kiểm tra .....

Người ghi và đơn vị .....

| Giường hoặc khu vực | Hỏng, dột hoặc bất cập | Khắc phục và hạn | Nghiệm thu |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Nhận xét, tồn tại hoặc thông tin cần xác minh .....

Hành động tiếp theo, người phụ trách và hạn .....

Người kiểm tra, ngày và kết quả xác nhận .....

Ghi theo thực tế, không xác nhận trước; lưu trong hệ thống được phân quyền. Cần thêm dòng thì sao chép trang biểu mẫu hoặc tích hợp vào hệ thống chính thức.

## 6 BM04 Báo cáo và cải tiến

Mã đề xuất A21 BM04.

Kỳ, người lập, số giường kế hoạch và thực kê .....

Người ghi và đơn vị .....

| Tồn tại từ dữ liệu | Nguyên nhân | Giải pháp và người phụ trách | Kết quả kiểm tra lại |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Nhận xét, tồn tại hoặc thông tin cần xác minh .....

Hành động tiếp theo, người phụ trách và hạn .....

Người kiểm tra, ngày và kết quả xác nhận .....

Ghi theo thực tế, không xác nhận trước; lưu trong hệ thống được phân quyền. Cần thêm dòng thì sao chép trang biểu mẫu hoặc tích hợp vào hệ thống chính thức.

## 7 Danh mục minh chứng và tự đánh giá

| Nhóm | Hồ sơ cần tập hợp | Mã và vị |
|---|---|---|
| MC01 | Quy định, quyết định phân công, nguồn lực và phê duyệt. | |
| MC02 | Hồ sơ phổ biến, đào tạo, kiểm tra thực hành và học bù. | |
| MC03 | Biểu mẫu đã thực hiện, dữ liệu nguồn, quan sát và phỏng vấn. | |
| MC04 | Chỉ số, báo cáo, phản hồi, cải tiến và đo lại. | |
| MC05 | Hồ sơ phản ánh, sự cố và xác minh tình trạng mức 1. | |

Kỳ đánh giá và phạm vi .....

Tình trạng mức 1 và bằng chứng xác minh .....

Mức đề xuất sau kiểm tra tích lũy .....

Khoảng thiếu và người chịu trách nhiệm .....

Người lập và người kiểm tra .....

Có bộ hồ sơ không đồng nghĩa đạt tiêu chí. Phải kiểm tra hoạt động tại hiện trường và đối chiếu dữ liệu nguồn; các trường hợp chưa xác minh giữ nguyên trạng thái chưa xác minh.

## Phụ lục tự đánh giá tiểu mục 1 đến 12

Kỳ và người kiểm tra .....

| Mục | Thực trạng hoặc mức đáp ứng | Mã minh chứng | Việc cần bổ sung |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |

Mục 1 ghi có/không tình trạng bất lợi. Các mục khác ghi đáp ứng/chưa đáp ứng/chưa xác minh. Trường hợp không áp dụng chỉ sử dụng khi hướng dẫn cho phép và có căn cứ. Người kiểm tra: .....

## Phụ lục tự đánh giá tiểu mục 13 đến 17

Kỳ và người kiểm tra .....

| Mục | Thực trạng hoặc mức đáp ứng | Mã minh chứng | Việc cần bổ sung |
|---|---|---|---|
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |

Mục 1 ghi có/không tình trạng bất lợi. Các mục khác ghi đáp ứng/chưa đáp ứng/chưa xác minh. Trường hợp không áp dụng chỉ sử dụng khi hướng dẫn cho phép và có căn cứ. Người kiểm tra: .....

## 8 Nguồn và kiểm tra trước ban hành

[1] Bộ Y tế. QĐ6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016, tiêu chí A2.1, trang in 26.

https://trungtamytehuyentanyen.vn/public/uploads/files/quyet-djinh-6858qdj-byt-nam-2016-ve-bo-tieu-chi-chAt-luong-benh-vien-viet-nam-do-bo-truong-bo-y-te-ban-hanh_5faed01464.pdf

Ngày đối chiếu nguồn 16/10/2026. Bộ phận phụ trách xác nhận hướng dẫn kiểm tra áp dụng cho kỳ đánh giá thực tế; đối chiếu thêm TT35/2024/TT-BYT về tiêu chuẩn chất lượng cơ bản đối với bệnh viện khi lập hồ sơ chất lượng chung.

□ Điền số văn bản, phiên bản, ngày áp dụng và người có thẩm quyền.

□ Chốt đầu mối, nguồn lực, lịch triển khai và mục tiêu từ thực trạng.

□ Rà soát nội dung, biểu mẫu và quy định chuyên môn, pháp lý liên quan.

□ Phê duyệt, phổ biến và kiểm tra việc áp dụng.

□ Bổ sung dữ liệu và minh chứng thật trước khi ký kết luận mức đạt.